

## 齒顎矯正治療注意事項

親愛的矯正病友及家屬，您們好！

齒顎矯正的治療，雖然能帶給患者整齊的牙齒、良好的咬合及迷人的微笑，但如同所有的醫療行為，過程中存在著一些不確定的因素，因此無法百分之百地保證能達到預期的治療效果。不過，若您在治療前充分了解治療的流程、臉型、顎骨骨架與牙齒之問題所在及治療可能發生的潛在問題，並且充分與醫師合作，則將有最大的可能會得到良好且令人滿意的治療效果。

### Part I. 矯正治療前

1. 治療流程：一般的齒顎矯正治療流程如下：(1) 初診諮詢 → (2) 治療前必要資料（如生長記錄、石膏模型、口內外之 X 光檢查、臉部及口內之相片、電腦斷層掃描等）的收集 → (3) 病例分析及綜合診斷 → (4) 訂定一種或以上的治療計畫 → (5) 聽取治療計畫、說明與討論 → (6) 定期積極性矯正治療 → (7) 治療中、後必要資料之收集 → (8) 維持器配戴 → (9) 定期複診。
2. 治療前，應將蛀牙、牙周病、阻生智齒或是更換假牙等一般牙科治療處理完成。但在某些特殊情況下，則需在矯正治療一段時間後，才能妥善的治療，如兩顆牙齒的鄰接面蛀牙等。
3. 異常咬合常會造成一些牙齒有不正常磨耗（過度或不規則）或完全未磨耗等現象。於治療前、中、後，為配合整體美觀及咬合高度的一致，醫師常須做定期或必要的牙齒修形。還有一些病例，如因上、下牙齒之比例不正常或某些因素，而須對牙齒的鄰接面做必要修形時，醫師也會於聽取矯正報告時告知。
4. 由於牙齒的大小、形狀或數目的缺失等，會因人而異。若有較異常者，可能需要牙科的其他分科配合處置，才能達到良好的治療效果。最常須共同配合的有牙體復形科、鑲復牙科及牙周病科等。若有需要，矯正醫師會轉診並請患者或家長與各科醫師們諮詢討論。
5. 矯正治療可能須配合口腔外科的合併治療，尤其在牙齒擁擠或因改善臉型而需拔牙的情況。在某些伴有上、下顎骨異常的病例，若異常情況愈嚴重，則合併正顎手術治療的機率則愈高。通常，矯正醫師會轉診或會診口腔外科或整形外科醫師，並請患者或家長與上述醫師們諮詢討論。
6. 矯正治療的費用會因患者的異常咬合之狀況、骨骼之因素、矯正器種類之不同、拔牙與不拔牙之治療等，而有所不同。至於伴有合併正顎手術之治療，則手術之相關費用不包含在矯正治療費用內。
7. 患者若有精神障礙、顫顫關節或全身性疾病，均會影響矯正治療之進行與成效。應預先告知醫師您的健康狀況及相關的變化。

### Part II. 矯正治療中

齒顎矯正治療在臨床上有其潛在問題及治療的極限。幸好，這些情況很少發生，不過，在您決定接受矯正治療後，對下述治療中可能發生的問題仍須充分地了解。

#### 牙齒與牙周的問題

1. 常吃含高糖的食物飲料或不當口腔衛生時，可能會有牙齒表面脫鈣、蛀牙或牙周病的發生。雖然這些問題也會發生在未受矯正治療之患者，但接受矯正治療的患者因口腔衛生較難維護，故罹患率也較高。
2. 如果牙周組織是在不健康的狀況下，將會受到矯正治療的影響。若無良好的口腔衛生，尤其每天不將牙菌斑清除乾淨，就會造成牙齦發炎及齒槽骨的異常吸收。
3. 牙根吸收的可能性：在矯正移動牙齒時，有些患者的牙齒的根尖長度可能會變短，通常這種短化的現象很輕微且無臨床意義，亦即牙齒的功能不受此影響。不過在極少數的病例中，可能會造成對牙齒的壽命或穩定性的不良影響，若於定期全口 X 光片中有發現這類狀況，會再由醫師評估並和您討論可能的處理方式。

4. 因深層蛀牙而填補的牙齒或受外傷的牙齒，其齒內神經可能已受損。有些病例會因矯正牙齒的移位，可能使受損的程度更加惡化，甚至須接受根管治療。
5. 牙周黑三角（black triangle）：牙齒在經過矯正治療後，有可能會在齒頸部位置產生黑三角的現象。這個現象的成因為排列整齊後的牙齒中間的齒槽骨距離通常更大，但是原本牙齒中間的齒槽骨並沒有重新增長的能力，因此在某些條件下（例如成人矯正、治療前牙齒排列就較為凌亂等等）更有可能發生黑三角的狀況。若牙齒尺寸大小本身有異常，可於矯正過程中使用牙齒修形（stripping）方式處理，其餘狀況建議於矯正治療後以美學樹脂、牙周手術等方式修復。

### 裝置意外、材質及移動牙齒的問題

1. 矯正裝置是由許多小而精緻的組件所連結而成，所以有可能意外地誤吞入肚子、誤吸入氣管或使口腔軟組織受到刺激或受傷。臉頰與嘴唇也可能會因鬆脫、斷裂的裝置而刮傷、刺傷。
2. 每次調整後，病人可能會有觸痛、酸軟或對冷熱敏感的反應。這種現象會持續 3 至 5 天後而逐漸緩和，但會因個人體質、矯正力量、方向與受力分佈的情況而有所不同。只要有任何明顯的症狀，或裝置有鬆脫、斷裂發生時，應儘快告知您的矯正醫師儘早處置。
3. 口外裝置如果被不當地使用或受到外力撞擊時，可能會造成臉部或眼睛的傷害。雖然有些口外裝置附有安全配備，但請勿在進行喧鬧、運動或其他比賽活動時配戴。
4. 所有的矯正裝置都有其特殊的作用，因此裝置的類型、構造與材質均不同。非常少數患者可能會對矯正裝置材質的成分產生過敏反應，而須改變裝置或終止矯正治療。
5. 使用某些透明或牙齒顏色的矯正器（bracket）時，如陶瓷矯正器，有可能會造成對咬牙的磨損或拆卸時的牙齒表面受損。
6. 若矯正器或其他口內裝置，是因患者之不當施力，如碰撞或咬堅硬的食物等所造成，而經常須重新將矯正器重黏至牙齒上時，則須另外付費，也會耽誤療程。

### 牙齒移動異常與治療時長相關問題

1. 牙齒的發育與萌發是個錯綜複雜的過程。有時牙齒會與骨頭黏連在一起而無法萌出或移動。黏連牙的診斷一般較為困難，可能只是發生在牙根的一個特定位置，此時即使使用 X 光也無法正確地判讀。若有此現象發生，通常需配合黏連牙的外科手術再繼續進行矯正治療，或是只好拔除以利整體矯正治療。
2. 牙齒的異常形成或顎骨發育有異常的改變時，都會因超出矯正醫師所能控制的範圍而影響矯正治療的結果。有時矯正治療後，會因上述生長因素而改變原始治療計畫，甚至需待生長結束後再施以正顎手術，而這可能會再造成醫療費用以及時程的增加。
3. 整體治療的時間可能會超出當初的估算：顎骨發育過盛或不足、矯正裝置或橡皮筋裝戴的時間不夠、缺乏合作性、口腔衛生不佳、矯正裝置常破損、脫落或遺失、常更改預約時間或爽約及其他原因等，都會延誤治療時間和影響治療結果。若有上述原因造成的治療時程延宕，則會有相關額外的醫療費用產生。

### 顫顎關節及正顎手術的問題

1. 有時顫顎關節會發生問題，產生疼痛、頭痛或耳朵區域的症狀。這些問題都可能會發生在未受矯正治療或施行矯正治療的病人身上。若有上述明顯的情況，則應儘早告知矯正醫師。
2. 矯正治療可能須配合口腔外科如拔牙、皮質骨切斷術、迷你骨釘或／及骨板固定手術或正顎手術的合併治療。尤其在牙齒擁擠、黏連牙、錨定需求度高或重度顎骨位置異常的情況下，需要牙科各次專科醫師的團隊合作，才能提供您較完整的治療，因此各專科之間的會診協調會較為費時。在決定這些治療前，應該與家庭牙醫、負責手術的口腔外科醫師等，討論有關手術與麻醉的可能發生之問題。
3. 矯正治療合併正顎手術的相關事項：
  - A. 若上下顎骨異常的情況嚴重時，最好合併正顎手術治療修正骨架。若醫師提供不手術治療計畫時，務必要了解不手術的代價、併發症及能達到的效果為何。治療中更換計畫可能會造成治療結果不佳、治療時間大幅延長，甚至牙周、牙齒的額外傷害。

- B. 在正顎手術前的矯正治療，是將上、下顎的牙齒分別移動至顎骨的理想位置。因上、下顎骨的相對關係原本就異常，所以手術前的矯正治療，可能會暫時地使臉型與咬合更加惡化，但這種情況在手術後即可迅速獲得改善。
- C. 若患者要求將既定的矯正治療合併正顎手術的計畫，改變為單純的齒顎矯正治療，則除了治療時間、矯正費用會增加外，且無法達到原先預期之整體治療效果，上下門齒軸向可能因為遷就顎骨關係異常而無法調整到理想角度。
- D. 手術治療計畫若有變更，應與您的家庭牙醫及外科醫師諮詢討論。
- E. 在決定是否接受矯正合併正顎手術治療前，需要先與外科醫師諮詢手術的時間、費用、裝置、效果及可能發生的潛在問題。

### Part III. 矯正治療後

經過矯正治療後，牙齒仍有往原來位置移回的傾向，稱為復發現象（relapse）。一般而言，下顎前牙區的牙齒是最易發生的區域。復發時，牙齒的排列會逐漸有擁擠的現象，且會隨著時間而日趨嚴重。確實地裝戴維持器（retainer）可減少這種傾向的發生。

1. 人體的上、下牙齒的咬合是屬於消耗性器官的一種，幾乎每天都在使用且磨耗，在正常的情況下持續發生微小的變化。
2. 牙齒的咬合關係會因各種不同的原因而有所改變，例如：(1) 智齒的異常萌發 (2) 牙周病的發生或惡化 (3) 受遺傳影響的舌頭之大小 (4) 舌頭之不正常運動，如發音或吞嚥異常 (5) 顎骨的生長和發育 (6) 身心成熟度的改變 (7) 口呼吸 (8) 吹奏樂器 (9) 不良的口腔習慣，如咬指甲等 (10) 其他，如多生牙或囊腫等，而這些因素都有可能超出矯正醫師所能控制的範圍。
3. 維持器裝戴的時間會因 (1) 患者的年齡、治療的時機與部位 (2) 移動的距離與方向 (3) 維持器的種類不同等，所需裝戴的時間也不一樣。
4. 活動式（removable type）維持器應整日裝戴，而裝戴的時間至少需半年到 2 年不等。若有遺失則應儘快重新製作，以免咬合有復發的狀況發生，且重新製作須另外付費。
5. 固定式（fixed type）維持器裝戴的時間一般都較活動式的時間長。若固定於維持器的樹脂於半年內有脫落的情形，我們將免費予以再固定；若超過此時限而須再黏著固定時，則須另外付費。
6. 一般而言，維持器使用越久，咬合穩定性可維持越久。但必須遵照齒顎矯正醫師所指示時間範圍內整日裝戴。之後，若要長期的穩定，則晚上睡覺時裝戴即可。
7. 矯正治療後的完美成果，就如同汽車的使用，需定期且長期的保養與照顧。故需要定期回診追蹤矯正成果（大約半年複診一次，若有增減會於該診次與您討論），以便有問題發生時矯正醫師就可立即處置。
8. 若是屬於兩階段或多階段治療的病例，更應遵照醫師指示的時間回診，才能繼續完成整體的矯正治療。否則，可能會隨著牙齒的替換及骨骼之生長發育不正常，又造成異常咬合的現象。
9. 若異常咬合的復發，是因患者的合作性不佳，或因不尋常的生長形態而超出矯正醫師所能控制的範圍，而日後須再進行另一次的矯正治療時，將重新評估與計算治療費用。

本文件全文同步刊載於本診所線上衛教頁，掃描 QR code 即可隨時查閱；如有疑問，請於回診時與醫師討論。是否已詳閱本注意事項，將於「矯正自費暨治療同意書」中勾選確認。